丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床疗效研究

赵君
201700 复旦大学附属中山医院青浦分院神经内科，上海

摘　要　目的：分析脑梗死后出现失语症患者采用丁苯酞氯化钠治疗的效果。方法：选取2023年1月—2024年10月复旦大学附属中山医院青浦分院的88例脑梗死后出现失语患者作为研究对象，采用随机分组法将患者分为对照组、观察组。对照组给予常规治疗，观察组在对照组基础上使用丁苯酞氯化钠进行治疗。对比两组患者治疗效果。结果：观察组治疗后神经功能缺损评分低于对照组，日常生活能力、失语指数评分高于对照组（$P < 0.001$）。观察组治疗后总有效率高于对照组（P=0.012）。观察组语言功能各项指标评分高于对照组（$P < 0.001$）。结论：脑梗死失语症患者采用丁苯酞氯化钠进行治疗，能明显改善神经功能缺损情况，促进患者语言功能及日常生活能力恢复。

关键词　脑梗死；失语症；丁苯酞氯化钠注射液；神经功能
中图分类号　R743.3　　**文献标识码**　A

Clinical Efficacy of Butylphthalide Sodium Chloride Injection in the Treatment of Aphasia after Cerebral Infarction

Zhao Jun
Department of Neurology, Qingpu Branch of Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai 201700, China

Abstract　Objective: To analyze the effect of treatment with butylphthalide sodium chloride in patients who developed aphasia after cerebral infarction. Methods: Eighty-eight patients who developed aphasia after cerebral infarction in Qingpu Branch of Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University from January 2023 to October 2024 were selected as the study subjects, and the patients were divided into the control group and the observation group by using the method of randomized grouping. The control group was given conventional treatment, and the observation group was treated with butylphthalide sodium chloride on the basis of the control group. Compare the treatment effects of the two groups of patients. Results: The score of neurological deficits in the observation group was lower than that of the control group, and the score of aphasia index and the ability of daily life were higher than that of the control group ($P < 0.001$). The total effective rate after treatment of the observation group was higher than that of the control group (P=0.012). The scores of language function indexes in the observation group were higher than those in the control group (P<0.001). Conclusion: The treatment of cerebral infarction aphasia with butylphthalide sodium chloride can significantly improve the neurological deficits and promote the recovery of patients′ language function and daily life ability.

Key words　Cerebral infarction; Aphasia; Butylphthalide sodium chloride injection; Neural function

脑梗死又称为缺血性脑卒中，是由于大脑血液循环障碍引起的脑组织局部缺氧、缺血，导致大脑组织发生坏死[1]。脑梗死与动脉粥样硬化、血栓形成有关，其不仅致残率高，而且致死率也较高。失语是脑梗死的常见后遗症，据统计脑梗死患者救治成功后遗留失语率 > 30%，对患者的正常生活造成严重影响[2-3]。丁苯酞的活性成分是dl-3-正丁基苯酞，作为人工合成消旋体，可以帮助患者重建脑缺血区的微循环状态，对神经功能改善具有显著作用。基于此本研究分析丁苯酞氯化钠治疗脑梗死后失语症的临床治疗效果，现报告如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取2023年1月—2024年10月复旦大学附属中山医院青浦分院的88例脑梗死后出现失语患者作为研究对象，采用随机分组法将患者分为对照组、观察组。对照组男24例，女20例；年龄46～75岁，均值（58.12±5.47）岁；病程7～15 d，均值（10.63±1.52）d；体质量指数16～27 kg/m^2，均值（23.52±1.16）kg/m^2。观察组男25例，女19例；年龄45～74岁，均值（59.28±4.65）岁；病程6～15 d，均值（10.78±1.49）d；体质量指数17～27 kg/m^2，均值（23.42±1.13）kg/m^2。两组一般资料比较，差异无统计学意义（$P > 0.05$），具有可比性。患者

中国知网　https://www.cnki.net

签署知情同意书。本研究经医院伦理委员会审核批准。

1.1.1 纳入标准 患者符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]相关诊断标准。存在运动性失语患者。伴有神经功能缺损。急性起病。伴明显神经功能缺损。发病<24 h。临床资料完整。

1.1.2 排除标准 伴明显交流障碍。严重肝、肾功能不全。对丁苯酞有过敏反应。具有记忆力减退并伴有认知障碍者。

1.2 方法 对照组采用常规治疗,阿司匹林(生产厂家:Bayer Health Care Manufacturing S.r.l.;批准文号:国药准字HJ20160685)口服,100 mg/次,1次/d;氯吡格雷片(生产厂家:Sanofi Winthrop Industrie;批准文号:国药准字HJ20171238)口服,首次剂量为300 mg/次,1次/d,治疗21 d后改为75 mg/次,1次/d,连续治疗3个月。同时,根据患者病情给予降血压、降血糖等药物对症治疗。观察组在对照组基础上应用丁苯酞氯化钠注射液(生产厂家:石药集团恩必普药业有限公司;批准文号:国药准字H20100041)100 mL静脉滴注治疗,2次/d,连续治疗2周。

1.3 观察指标及疗效判定标准

1.3.1 神经功能缺损程度 根据美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评价患者的神经功能缺损程度,总分42分,分数越高说明神经功能缺损情况越严重。

1.3.2 日常生活能力 采用日常生活能力交流量表(CADL)对患者独立自主能力进行评价,分为完全独立自主(115~135分)、部分可自主(80~114分)、需要家庭帮助(40~79分)、全面需要家庭帮助(<40分),评分越高表明患者的日常生活能力恢复越好。

1.3.3 失语指数 根据失语商(AQ)评价患者失语程度,正常96~98分,部分语言障碍90~95分,失语<90分,评分越高表明患者的语言功能恢复越好。

1.3.4 临床疗效 治愈:NIHSS评分降低90%~100%,语言功能恢复到正常交流水平;显效:NIHSS评分降低50%~89%,语言功能大部分恢复;有效:NIHSS评分降低20%~<50%,语言功能有所好转;无效:NIHSS评分降低<20%,语言功能无好转。总有效率=治愈率+显效率+有效率。

1.3.5 语言功能评价 采用西方失语症成套测验(WAB)对患者语言功能进行评价,分数为百分制,分数与患者语言功能恢复成正比。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 22.0统计学软件分析,计数资料以n(%)表示,采用χ^2检验;计量资料以$\bar{x}\pm s$表示,采用t检验;$P<0.05$说明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者NIHSS、CADL、AQ评分比较 两组患者治疗前NIHSS、CADL、AQ评分对比,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组NIHSS评分低于治疗前($P<0.05$),CADL、AQ评分高于治疗前($P<0.05$);观察组治疗后NIHSS评分低于对照组($P<0.05$),CADL、AQ评分高于对照组($P<0.001$)。见表1。

2.2 两组临床疗效比较 观察组治疗后总有效率高于对照组(P=0.012)。见表2。

2.3 两组患者语言功能情况比较 两组患者治疗前口语理解、复述、命名、自发言语评分对比,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组口语理解、复述、命名、自发言语评分高于治疗前($P<0.05$),且观察组高于对照组($P<0.001$)。见表3。

表1 两组患者NIHSS、CADL、AQ评分比较($\bar{x}\pm s$,分)

组别	n	NIHSS		CADL		AQ	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	44	8.35±2.79	4.10±1.05*	65.23±18.12	102.98±22.78*	40.43±7.28	76.60±17.72*
对照组	44	8.30±2.81	6.13±1.75*	66.12±17.46	85.16±20.54*	41.05±6.87	54.16±8.53*
t		0.083	6.598	0.234	3.853	0.413	7.568
P		0.933	<0.001	0.815	<0.001	0.682	<0.001

注:与本组治疗前比较,*$P<0.05$。

表2 两组临床疗效比较[n(%)]

组别	n	治愈	显效	有效	无效	总有效
观察组	44	23(52.27)	14(31.82)	5(11.36)	2(4.55)	42(95.45)
对照组	44	13(29.55)	15(34.09)	6(13.64)	10(22.73)	34(77.27)
χ^2						6.175
P						0.012

中国知网 https://www.cnki.net

表3 两组语言功能比较($\bar{x}\pm s$,分)

组别	n	口语理解		复述		命名		自发言语	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	44	15.20±2.15	23.49±0.35*	15.49±1.49	23.35±1.62*	16.18±1.44	23.52±1.47*	16.22±0.85	22.38±1.02*
对照组	44	15.15±2.18	20.46±1.14*	15.52±1.48	19.10±1.49*	16.13±1.52	20.30±1.45*	16.23±0.82	19.55±1.03*
t		0.082	12.063	0.051	15.741	0.014	12.048	0.085	12.950
P		0.916	< 0.001	0.914	< 0.001	0.829	< 0.001	0.918	< 0.001

注:与本组治疗前比较,*$P < 0.05$。

3 讨论

急性脑梗死是中老年人群常见的脑血管疾病,发病后患者多伴随神经功能缺损、语言功能障碍,影响患者日常生活,对后续康复产生不良影响[5-6],因此急性脑梗死患者应及早治疗。有研究发现[7],当大脑受到损伤时,内皮质区域的乙酰胆碱递质水平下降,进而影响语言沟通能力、记忆力、注意力,导致功能障碍[7]。当前临床对于脑梗死后失语症多采用药物治疗,但是疗效不显著,因此积极寻找一种有效治疗方法非常重要[8]。

本研究结果显示,观察组治疗后NIHSS评分低于对照组,CADL、AQ评分、总有效率、语言功能各项指标评分高于对照组($P < 0.05$)。可见丁苯酞注射液治疗脑梗死后失语症,可以明显提高临床疗效,改善患者的脑神经功能损伤,促进患者语言功能及日常生活能力恢复。分析原因:胆碱是中枢神经系统的关键指标,其不仅能保护神经元功能维持正常活动,还能对受损神经起到改善作用。选择性胆碱酯酶抑制剂通过抑制中枢胆碱酯酶活性,减少内源性乙酰胆碱的降解,从而维持胆碱含量。丁苯酞氯化钠注射液可降低一氧化氮含量,控制酶活性,保护神经血管,促进神经功能恢复,降低炎性反应,改善脑水肿,增强神经元的抗氧化和抗凋亡能力,显著改善患者的后续恢复效果[9]。另外,丁苯酞氯化钠注射液能够重建微循环,恢复缺血区的障碍,增加毛细血管数量,增强代偿作用,减少脑梗死后的继发性损伤。同时,该药物可保护线粒体,避免缺血细胞凋亡加重,改善能量代谢,减轻线粒体肿胀,稳定空泡化线粒体膜,逆转线粒体膜流动性,显著提升线粒体复合酶Ⅳ和三磷酸腺苷酶活性,控制缺血区细胞坏死,减轻缺血缺氧脑损伤,避免患者出现记忆障碍,促进语言功能尽早恢复[10],从而提高患者的生活能力。

综上所述,脑梗死后出现失语患者采用丁苯酞氯化钠进行治疗后效果明显,可以明显改善脑神经功能缺损情况,促进患者语言功能及日常生活能力恢复,可推广应用。

参考文献

[1] 阳强.丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床效果[J].临床合理用药,2024,17(19):77-80.

[2] 宋涛.针刺联合丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语临床研究[J].新中医,2023,55(19):167-171.

[3] 李丽.丁苯酞氯化钠注射液治疗急性脑梗死后失语患者的临床疗效[J].中国实用医药,2023,18(22):84-86.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):17.

[5] 左雪梅.应用丁苯酞注射液治疗脑梗死后失语患者及对生活质量影响分析[J].中国保健营养,2022,32(22):148-150.

[6] 余洋,刘少哲,苏醒,等.丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语的效果分析[J].深圳中西医结合杂志,2021,31(2):97-98.

[7] 张丽,常婷婷.丁苯酞注射液治疗脑梗死后失语临床疗效及对语言功能的影响分析[J].贵州医药,2023,47(1):68-69.

[8] 陈俊斌,陈鹏,谷玉平,等.用丁苯酞注射液治疗脑梗死后失语的可行性及安全性[J].当代医药论丛,2021,19(15):56-57.

[9] 覃丽君.丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语的效果及对患者语言功能的影响[J].当代医药论丛,2021,19(13):112-114.

[10] 董涛.观察丁苯酞注射液治疗脑梗死后失语患者的临床效果及对语言功能的影响[J].大医生,2022,7(22):13-16.

中国知网 https://www.cnki.net